Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent13vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5032753-91.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: REGINA TAAM

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

RÉU: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

VISTOS, ETC.

REGINA TAAM, qualificada, ajuizou ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER*** em face de UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA, igualmente qualificada, alegando ser a demandada responsável pelo fornecimento do medicamento *BEVACIZUMABE (AVASTIM 100 MG)*, prescrito para o tratamento de gliobastoma difuso (CID C72.9), representativo de câncer agressivo.

Argumentou ter a demandada negado a cobertura do medicamento, sob a justificativa de que seria *off-label,* porquanto a patologia acometida não constaria na bula do medicamento em questão. Argumentou ser indevida a negativa de cobertura, considerando que foi prescrito pelo médico assistente para o controle da doença. Requereu a concessão da tutela provisória, para que a ré fornecesse o medicamento por prazo indeterminado, nos exatos termos em que prescrito, sob pena de multa diária. No mais, requereu a ratificação da medida antecipatória. Deu à causa o valor de R$ 110.540,00. Juntou documentos (evento 1).

Intimada (evento 2), a demandante comprovou o pagamento das custas processuais (evento 6).

Intimada a retificar o valor atribuído à causa, esclarecer se o medicamento tem previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e juntar cópia do contrato celebrado com a ré (evento 8), a autora deu à causa o novo valor de R$ 211.080,00 e juntou documentos (eventos 11 e 13).

A emenda à inicial foi acolhida e a medida antecipatória, deferida (evento 14).

Citada, a ré apresentou contestação. Em preliminar, defendeu a ilegitimidade passiva, com fundamento na celebração de contrato de prestação de serviços entre a demandante e a Unimed Maringá, única operadora de plano de saúde que pode decidir sobre a cobertura do tratamento médico referido na inicial. No mérito, argumentou não ter responsabilidade pela cobertura do medicamento, bem como não ser a autora a sua beneficiária. Requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência do pedido (evento 26).

UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO compareceu ao feito de forma espontânea e apresentou defesa. Asseverou não ter a obrigação de proporcionar cobertura a medicamento para uso *off-label*, assim como a inexistência de comprovação da eficácia do fármaco para o tratamento da doença diagnosticada na demandante. Destacou ter sido prevista, no contrato de prestação de serviços, a ausência de cobertura em situações de uso de medicamentos em desacordo ao recomendado em bula. Alegou ser experimental o medicamento. Aduziu que a cobertura para casos não previstos no contrato ensejaria prejuízos aos demais beneficiários do plano de saúde. Postulou a improcedência do pedido. Anexou documentos (evento 28).

A requerida juntou documentação, defendendo o cumprimento da liminar (evento 31).

Houve réplica (evento 35).

Não houve interesse na dilação probatória (eventos 42 e 43).

Intimada (evento 47), a demandante informou a manutenção do interesse na inclusão, no polo passivo, de UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (evento 50).

A parte-ré reiterou as alegações da defesa (evento 53).

Determinou-se a inclusão de UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no polo passivo, dispensou-se a abertura de prazo para contestação, diante do comparecimento espontâneo da ré incluída ao feito, e intimaram-se as partes para que se manifestassem sobre o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol da ANS (evento 55).

As partes reiteraram as manifestações anteriores (eventos 59 e 62).

Vieram os autos conclusos para sentença (evento 65).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, não havendo necessidade de serem produzidas outras provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A **preliminar** de ilegitimidade passiva arguida pela ré UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA não merece acolhimento.

Observa-se que o contrato coletivo de plano de saúde, do qual a autora é beneficiária, foi celebrado com a ré UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (doc. 3 - evento 13):

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.

I – DA QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA

UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, atuando como Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, registrada na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 371254, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 76.767.219/0001-82, com sede na Av. Tiradentes, nº 1008, Maringá – Paraná, CEP: 87.013-260.

II – DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

ADUEM ASSOC DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE EST DE MARINGA, inscrito no CNPJ sob nº 77.924.637/0001-07, com endereço na R PROF ITAMAR ORLANDO SOARES, nº 305, Maringá - Paraná, neste ato representado pelo seu representante legal, a seguir denominada CONTRATANTE.

Embora a ré UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA não figure como contratada, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das operadoras do complexo Unimed do Brasil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pela recente decisão prolatada em 18/03/2022:

> ***AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.***
> *1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes - constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades -, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.*
> *2. É de rigor a incidência da Súmula n. 83/STJ, haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte.*
> *3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.*
> *4. Agravo interno desprovido*[1].

Como consequência da solidariedade, a demanda pode ser direcionada pela autora contra qualquer das integrantes do grupo Unimed no país, incluindo aquela com sede em Porto Alegre/RS.

Salienta-se que a ré UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO concordou com a sua inclusão no feito, como havia requerido a demandante, conforme reconhecido na decisão do evento 47, fundamento pelo qual a presente demanda pode prosseguir também em relação à operadora efetivamente contratada para gerir o plano de saúde coletivo do qual a autora é beneficiária.

Passo, então, ao **mérito**.

A relação travada nos autos é de consumo, enquadrando-se as demandadas como fornecedoras e a parte-autora, como consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor[2].

Cláudia Lima Marques doutrina acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro:

> *Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor. Note-se que o destinatário do prêmio pode ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, que participará como beneficiária do seguro. Nos dois casos, há um destinatário final do serviço prestado pela empresa seguradora. Como vimos, mesmo no caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado por especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço ou preposto), há a presença do 'consumidor' ou alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e seu parágrafo único.*[3]

Ademais, já é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 469, que "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.*"

A controvérsia reside na responsabilidade da parte-ré pela cobertura do medicamento *BEVACIZUMABE (AVASTIM 100 MG)*, prescrito para o tratamento de gliobastoma difuso (CID C72.9), representativo de câncer agressivo.

O laudo médico anexado na inicial (doc. 7 - evento 1) comprova que a demandante já fez uso dos demais medicamentos indicados para o tratamento da enfermidade que a acomete, entretanto, sem obter um resultado satisfatório, fundamento pelo qual foi prescrito o referido medicamento. Ademais, como apontado na decisão do evento 14, o referido laudo médico indica que a enfermidade que acomete a parte-autora é grave, reduz consideravelmente a sua qualidade de vida e representa risco de morte (doc. 7 - evento 1).

A negativa de cobertura decorreu por se tratar de indicação para uso *off-label* (doc. 11 - evento 1).

Merece acolhimento a tese da demandante de ilicitude na negativa de cobertura.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que se considera abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso *off-label*):

> ***RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.***
> *1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18.*
> *2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.*
> *3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.*
> *4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.*
> *5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).*
> *6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).*
> *7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.*
> *8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.*
> *9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).*
> *10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.*
> *11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.*
> *12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.*[4]

A conclusão, pois, é a de que se revela abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito à autora.

Ressalta-se, no ponto, que a parte-ré não comprovou a alegação de que o medicamento é experimental ou ineficaz para o tratamento da doença diagnosticada na autora, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sob outra perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento de taxatividade do rol da ANS[5], decisão referida no evento 55, não modificou o entendimento acima mencionado, para os casos de medicamento de uso *off-label*, razão pela qual se denota a abusividade na negativa de cobertura em casos como o do presente processo.

A conclusão, pois, é a de que se revela abusiva a negativa de cobertura para o medicamento prescrito à autora, fundamento pelo qual merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, devendo a parte-ré arcar com o custeio de todas as despesas relacionadas ao tratamento, por ser uma decorrência lógica da cobertura.

ISSO POSTO, julgo ***PROCEDENTE*** o pedido, forte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para, ratificando a medida antecipatória, **DETERMINAR** que a parte-ré, solidariamente, forneça cobertura para o tratamento indicado à autora, consistente no medicamento *BEVACIZUMABE (AVASTIM 100 MG)*, nos moldes em que prescrito, durante todo o período em que a demandante necessitar do fármaco.

Outrossim, ***CONDENO*** a parte-ré a arcar com as custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, que vão fixados em R$ 1.500,00, atualizados, pelo IGP-M, desde o arbitramento, com juros legais, a partir do trânsito em julgado, forte no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o grau de complexidade da causa, a desnecessidade de dilação probatória e o tempo de curso da lide no primeiro grau.

Em caso de interposição de apelação, abra-se prazo à adversa para contrarrazões, e, apresentadas ou decorrido o prazo, remetam-se ao e. TJ/RS, **sem necessidade de conclusão**.

Se nada for requerido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e, quitadas eventuais custas pendentes, arquive-se com baixa, sem necessidade de conclusão dos autos.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído separadamente no sistema Eproc, com novo número.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

INTIMEM-SE.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CARRAVETTA VILANDE, Juíza de Direito**, em 13/9/2022, às 19:21:0, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10024383481v71** e o código CRC **38d608c1**.

---

1. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.633/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022. ↩
2. Artigo. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.Artigo 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ↩
3. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: ed. RT, 1995, p. 141. ↩
4. REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) ↩
5. AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022. ↩